

Przeciwp przeniesienie w terapii NPD

Najwyższy odsetek przedwczesnego przerwania w klastrze B (~50% w 6 mies., Caligor 2015). Rupture-repair w aliansie = norma, nie porażka. Superwizja **obowiązkowa**.

CZAS: 15 min Dla terapeuty

ŹRÓDŁO: Safran & Muran (2000); Diamond (2014); Behary (2013); Gabbard (2009)

JAK UŻYWAĆ

1 · Rozpoznasz cztery typowe reakcje *kontrtransferencyjne* u terapeuty NPD (sekcja 01). **2** · Zrozumiesz *rupture-repair* jako **mechanizm zmiany**, nie porażki (sekcja 02). **3** · Wykonasz **autorefleksję** dla terapeuty pracującego z NPD (sekcja 03). **4** · Poznasz warunki bezpieczeństwa pracy: superwizja, własna terapia, mała liczba pacjentów (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

NPD jest jednym z **najtrudniejszych** zaburzeń osobowości w gabinecie — *najwyższy* wskaźnik przedwczesnego zakończenia terapii w klastrze B (Caligor i wsp. 2015), częste konflikty w aliansie, *ego-syntoniczne* objawy. Praca z *rupture-repair* (zerwanie-naprawa) w aliansie **nie** jest wyjątkową sytuacją — to *centralny* mechanizm zmiany. NPD wywołuje **silne przeciwp przeniesienie** (ang. *countertransference*): (1) *bycie idealizowanym* („jesteś najlepszym terapeutą!” → terapeuta czuje wyjątkowość, traci czujność); (2) *bycie dewaluowanym* („terapia nie działa, jesteś bezużyteczny” → wątplenie w sobie); (3) *nuda* (narcyz monologuje, terapeuta odpływa); (4) *irytacja* (arogancja, brak empatii pacjenta — terapeuta reaguje kontr-dewaluacją). **Superwizja jest koniecznością**, nie opcją. Safran & Muran (2000) pokazali w badaniach, że *repair* zerwanego aliansu jest **silniejszym predyktorem zmiany** niż brak zerwań w ogóle. *Pacjent testuje terapeutę*: czy wytrzyma dewaluację **bez** wycofania albo odwetu? Jeśli tak — formuje się *nowe doświadczenie relacyjne*: „mogę być *wściekły* i nie zostanę odrzucony”. To jeden z kluczowych mechanizmów zmiany w TFP. *Konsekwencja kliniczna*: niedoświadczony terapeuta interpretuje *rupture* w aliansie jako **własną porażkę** („źle pracuję”) albo **problem pacjenta** („on jest nieleczalny”). Reaguje wycofaniem, kontrtransferencyjną agresją albo kapitulacją. Terapia kończy się *przed* osiągnięciem zmiany strukturalnej. *Warunki bezpieczeństwa pracy*: regularna superwizja, własna terapia/analiza, tolerancja emocjonalna terapeuty. Bez tych zasobów praca z NPD grozi wypaleniem i szkodą dla pacjenta.

01 Cztery reakcje kontrtransferencyjne

1 · IDEALIZACJA

„Jesteś najlepszym terapeutą!” → terapeuta czuje *wyjątkowość*, traci czujność, daje preferencje. **Pułapka**.

3 · NUDA

Narcyz monologuje. Terapeuta odpływa myślami. *Nuda jest informacją*: pacjent nie w kontakcie z emocjami.

2 · DEWALUACJA

„Terapia nie działa, jesteś bezużyteczny.” Terapeuta wątpi w siebie, defensywnie reaguje albo kapitułuje. *Test pacjenta*.

4 · IRYTACJA

Arogancja, brak empatii. Terapeuta chce „postawić na miejscu”. Najczęstsze źródło *iatrogenii*.

02 Rupture-repair — mechanizm zmiany, nie porażki



Safran & Muran (2000): *repair* zerwanego aliansu jest **silniejszym predyktorem zmiany** niż brak zerwań w ogóle. *Rupture* to **materiał do pracy**, nie porażka. Centralny mechanizm zmiany strukturalnej w TFP i terapii schematów.

03 Autorefleksja dla terapeuty

CZY **LUBIĘ** TEGO PACJENTA BARDZIEJ, GDY MNIE IDEALIZUJE?

— *szczerze*

CZY CZUJĘ SIĘ **BEZWARTOŚCIOWY/-A**, GDY MNIE DEWALUUJE?

— *jaki własny schemat się aktywuje?*

CZY **NUDZĘ SIĘ** PODCZAS JEGO/JEJ SESJI?

— *co ta nuda mówi o sesji?*

CZY **CHCĘ GO/IĄ POSTAWIĆ NA MIEJSCU?**

— *gdzie czuję kontr-dewaluację?*

04 Warunki bezpiecznej pracy z NPD

1 · SUPERWIZJA REGULARNA Nie opcjonalna — konieczna.

Indywidualna lub grupowa. Co najmniej 2x w miesiącu dla każdego pacjenta z NPD. Pomaga widzieć pułapki, zanim się w nie wpadnie.

2 · WŁASNA TERAPIA/ANALIZA

Świadomość własnych schematów, w tym narcystycznych. Bez tego idealizacja przez pacjenta jest *uwodzicielska*; dewaluacja — *niezniszliwa*.

3 · MAŁA LICZBA PACJENTÓW

Pacjenci z NPD są *energochłonni*. Optymalnie: **2-4 pacjentów** z NPD jednocześnie, nie więcej. Reszta praktyki = inne diagnozy. Inaczej wypalenie.

Klucz: terapeuta, który „lubi” być idealizowany przez narcyza, jest w **pułapce**. Idealizacja zawsze prowadzi do dewaluacji — superwizja pomaga to widzieć, zanim się w to wpadnie. *Rupture* w aliansie z pacjentem z NPD **nie** jest porażką — jest *materiałem do pracy*. Safran & Muran (2000): *repair* jest silniejszym predyktorem zmiany niż brak *rupture*. Behary (2013) opisała *empathic confrontation*: „Rozumiem, że to boli — **i** widzę, jak to wpływa na innych”. *Limit setting*: jasne granice bez karania. **Nigdy** nie reaguj na dewaluację kontr-dewaluacją. Praca z NPD bez superwizji i własnej terapii grozi wypaleniem i szkodą dla pacjenta — to nie jest praca dla każdego klinicysty.